

Retilyv



Retilyv

Patologia Ano-Rectal Benigna

Dr.^a Ana Vilaça
Especialista em Medicina Interna
Luanda, 12 e 13/Julho/2023

The information contained in this slide kit is for the exclusive use of the doctor speaker, as part of training/ informative activities of Bial. Any changes made are full responsibility of the authors.

Disclaimers

- The images, texts and other materials published in this presentation may not be reproduced, rebroadcast, distributed or republished, in part or in full, unless the author has expressly given their prior written consent.
- This lecture was funded by BIAL.
- The scientific content selected and presented is of the author's responsibility.;
- This communication should not replace other sources of medical information, guidelines or the clinical judgment.
- BIAL advises the use of their medicines according to the approved indication.

Patologia Ano-Rectal Benigna

Patologias
**extremamente
frequentes!!**
As **primeiras
menções** a estas
patologias datam de
2500 A.C!

Fissura Anal

Doença Hemorroidária

**As mais
frequentes**

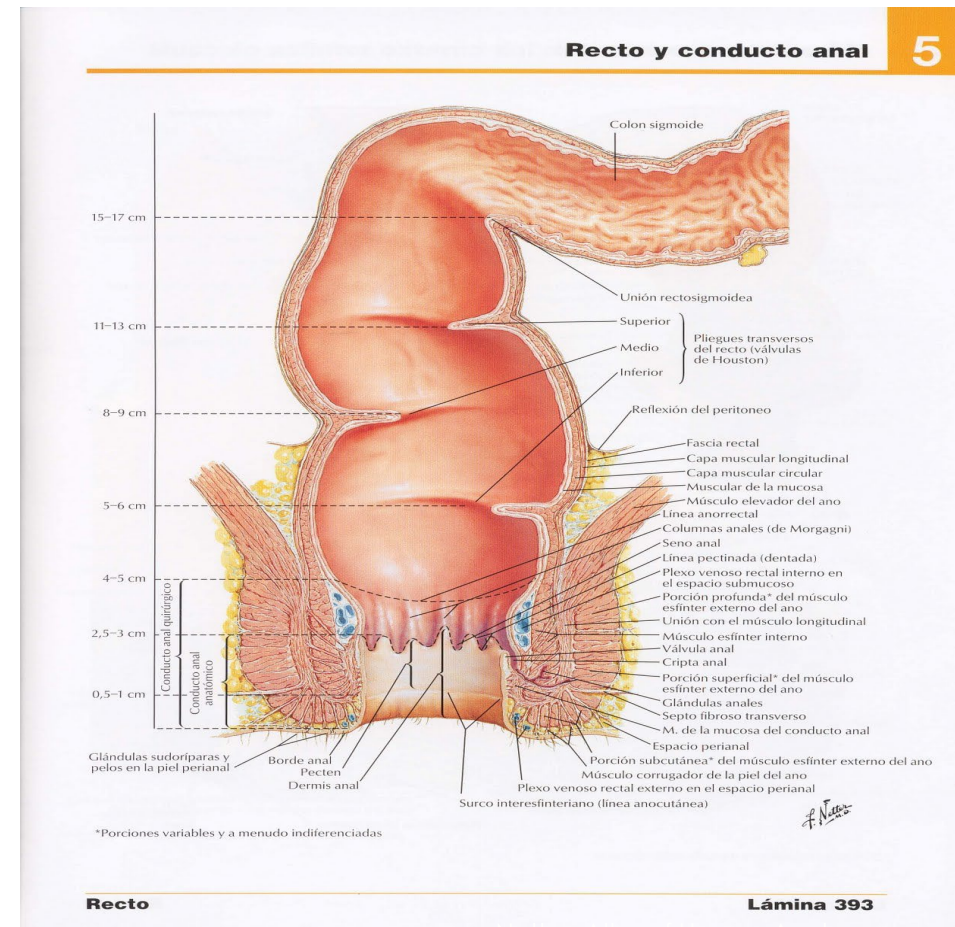
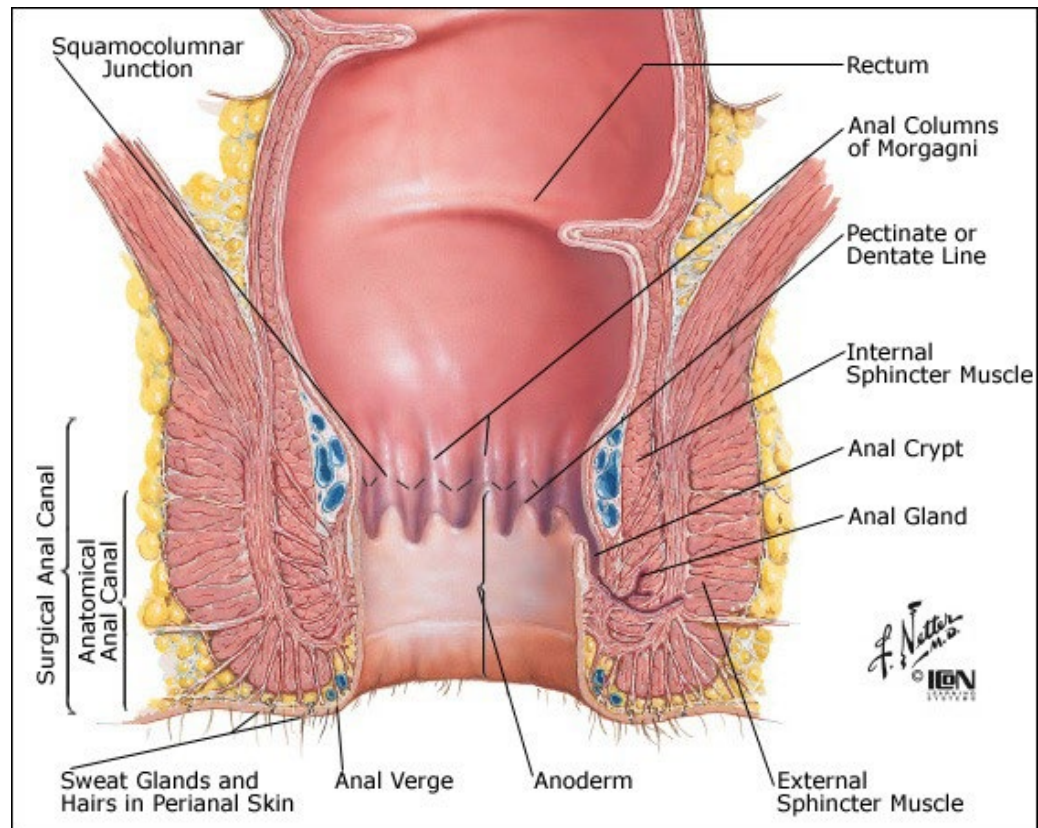
Abcesso e Fístula Perianal

1. Espinosa, D. J. (2000). Revisión analítica de estudios multicéntricos con policresuleno en patología hemorroidal. Acta gastroenterol. latinoam, 177-86.

2. Rakinic, J. e Poola, V. - Hemorrhoids and Fistulas: New Solutions to Old Problems. Current Problems in Surgery, Vol. 53, 3 (2014), p. 98-137

3. Rivadeneira, D., Steele, S., Ternet, C., Chalasani, S., Buie, W. e Rafferty, J. - "Practice Parameters for the Management of Hemorrhoids (Revised 2010)". Diseases of the Colon & Rectum, Vol. 54:9 (2011), p. 1059-1064

Anatomia

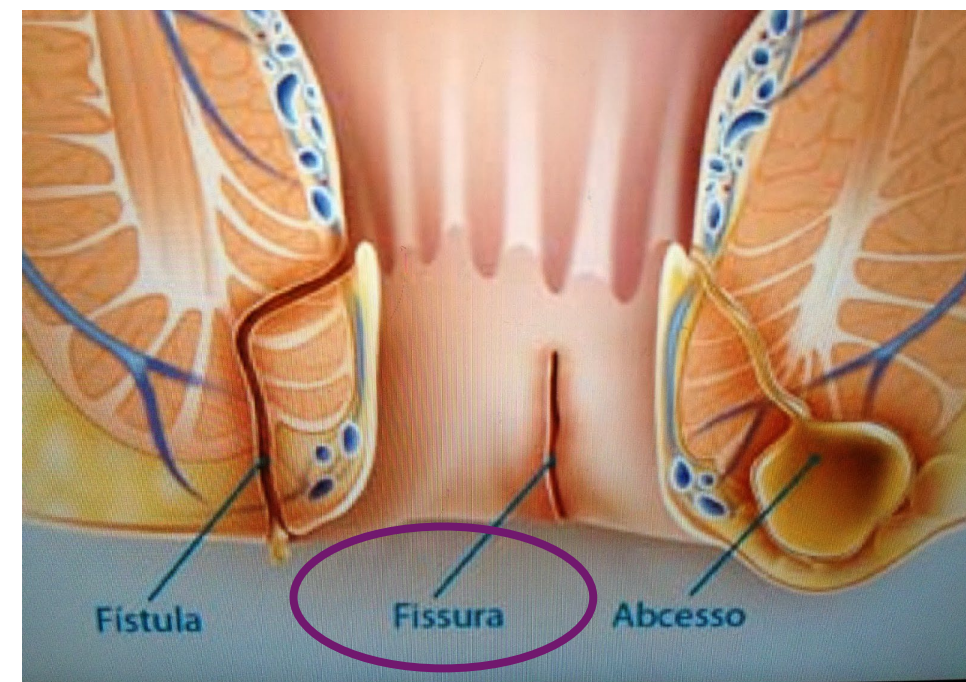




FISSURA ANAL

Definição

- ▶ Solução de continuidade do revestimento do canal anal
- ▶ **80 - 90% posteriores**
- ▶ **Anteriores:** em até **25%** das mulheres afectadas e **8%** dos homens afectados
- ▶ **Se laterais ou múltiplas** suspeitar de (doença de Crohn ; tuberculose; sífilis; HIV; psoríase; carcinoma anal; gonorreia; herpes; leucemia)



Epidemiologia

- ▶ Adultos jovens ou de meia-idade (20-60 anos)
- ▶ Incidência Homem = Mulher
 - ▶ 3º Trimestre da gravidez e pós-parto são períodos de maior predisposição



Etiopatogenia

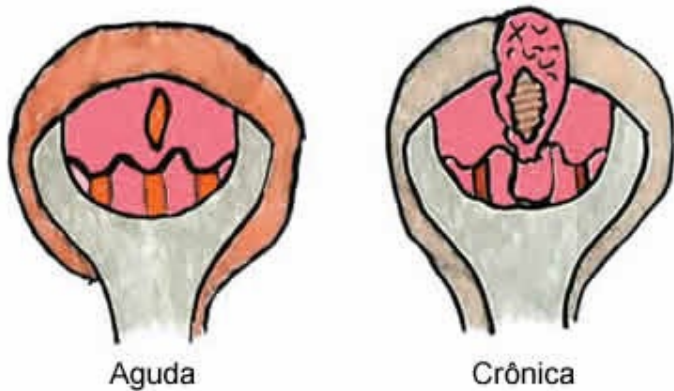
- ▶ **Factor iniciador:** traumatismo na passagem das fezes (fezes duras ou diarreia)
- ▶ **Factor perpetuante:** Hipertonia EAI
 - ▶ diminuição do óxido nítrico
 - ▶ leva ao colapso das arteríolas comprometendo a vascularização da **anoderme**

Classificação

Fissura Anal

Aguda - Crónica

- ▶ **Aguda** < 6 semanas
- ▶ **Crónica** > 6 semanas



Superficial - Profunda

- ▶ **Superficial:** envolve apenas a anoderme - bordos afilados.
- ▶ **Profunda:** edema e fibrose - bordos elevados exposição das fibras do esfíncter papila anal hipertrofia marisca sentinela

Sintomatologia

Fissura Anal

- ▶ Dor
- ▶ Rectorragia
- ▶ Prurido anal
- ▶ Tumefacção perianal (se for a marisca)



Diagnóstico

- ▶ História clínica
- ▶ Exame físico
- ▶ Se suspeitar de outras etiologias realizar:
 - ▶ endoscopia
 - ▶ biópsias
 - ▶ coproculturas

Exame Físico

Inspecção

✓ Fissuras superficiais



Tratamento

- ▶ **Objectivos:**
 - ▶ Alívio da dor
 - ▶ Reverter a hipertonia do EAI

**Médico
Cirúrgico**

Tratamento Médico

- ▶ **Dieta rica em fibras e aumento da ingestão de água**
- ▶ **Laxantes expansores volume fecal**
- ▶ **Laxantes osmóticos**
- ▶ **Banhos de assento**
 - ▶ após a defecação, imersão em água morna 2-5 min, seguida de imersão em água à temperatura ambiente 1 min.
- ▶ **Analgésicos sistêmicos**

Tratamento Médico

- ▶ **Analgésicos tópicos** (exemplo: Retilyv[®])
- ▶ **Corticóides tópicos**
- ▶ **Pomada Nitroglicerina (NTG)**
- ▶ **Bloqueadores canais de cálcio**
- ▶ **Toxina botulinica A**
 - ▶ eficácia semelhante à NTG
 - ▶ técnica não estandardizada

Tratamento Médico

- ▶ **90%** fissuras superficiais **curam** espontaneamente ou com **tratamento médico** simples
- ▶ TRATAMENTO 4-6 SEMANAS
- ▶ 2/3 das fissuras profundas entram em remissão com o tratamento médico
 - ▶ mas **18-67% recorrem**

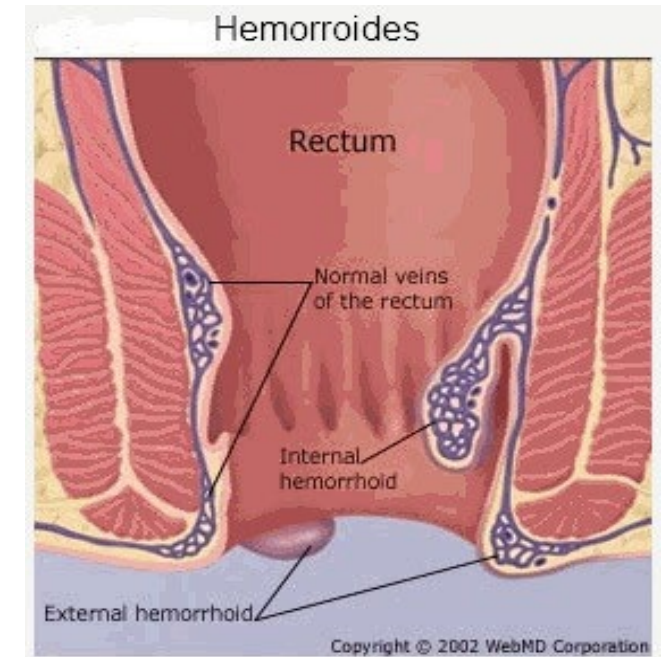
Tratamento Cirúrgico

- ▶ Persistência ou recorrência da fissura com tratamento médico
- ▶ Intolerância ao tratamento médico

DOENÇA HEMORROIDÁRIA

Definição

- ▶ **Hemorroidas - almofadas vasculares** que contribuem para o encerramento do canal anal e para a continência
 - anterior direita; posterior direita; lateral esquerda
- ▶ **Doença hemorroidária** - refere-se aos sintomas que surgem quando ocorrem **alterações do funcionamento e posição das hemorroidas**



www.googleimages.com

Epidemiologia

Doença hemorroidária

- ▶ **Muito frequente**
 - ▶ Estudos relatam **prevalências que variam de 4,4% a 86%**
- ▶ **Incidência Homem = Mulher**
 - ▶ **Gravidez agrava** e predispõe à doença hemorroidária (*geralmente resolução após o parto*)
- ▶ **Pode surgir na 3ª década de vida**
 - ▶ atingindo **pico entre 45-65 anos**

1. Deus, J. R., & Rama, N. Doença Hemorroidária-Recomendações (Guidelines) Hemorrhoidal Disease-Guidelines. Janeiro/Abril 2020.

2. Sun, Z., & Migaly, J. (2016). Review of hemorrhoid disease: presentation and management. Clinics in colon and rectal surgery, 29(01), 022-029.

3. Guttenplan, M. (2017). The evaluation and office management of hemorrhoids for the gastroenterologist. Current gastroenterology reports, 19(7), 1-8.

4. Salgueiro, P., Caetano, A. C., Oliveira, A. M., Rosa, B., Mascarenhas-Saraiva, M., Ministro, P., ... & Castro-Poças, F. (2020). Portuguese Society of Gastroenterology Consensus on the Diagnosis and Management of Hemorrhoidal Disease.

GE-Portuguese Journal of Gastroenterology, 27(2), 90-102.

Etiopatogenia

► Multifactorial

- Dieta (açúcares, farinhas, baixa quantidade de fibras → propiciam a doença hemorroidária)
- “Toileting behavior” (períodos prolongados no w.c.)
- Aumento pressão intra-abdominal (Asma, DPOC, Obesidade, Esforços físicos, Gravidez...)
- Obstipação; Uso prolongado de opióides; Diarreia crônica
- Genética



Classificação

Doença hemorroidária

► Hemorróidas Externas

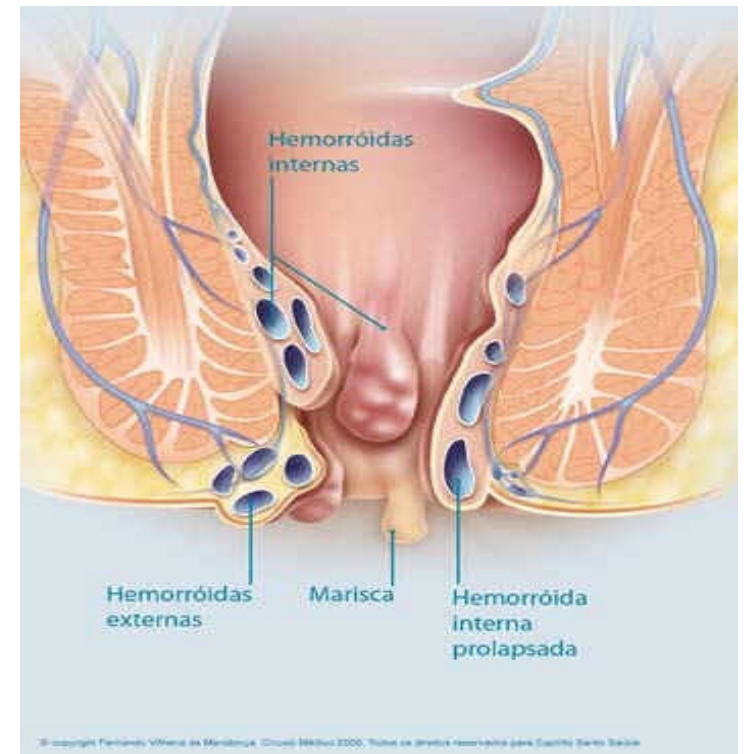
- revestidas por anoderme e pele perianal
- contêm os plexos vasculares distais à linha dentada

► Hemorróidas Internas

- revestidas por mucosa de transição
- contêm os plexos vasculares proximais à linha dentada

► Hemorróidas mistas

- Internas + Externas



www.googleimages.com

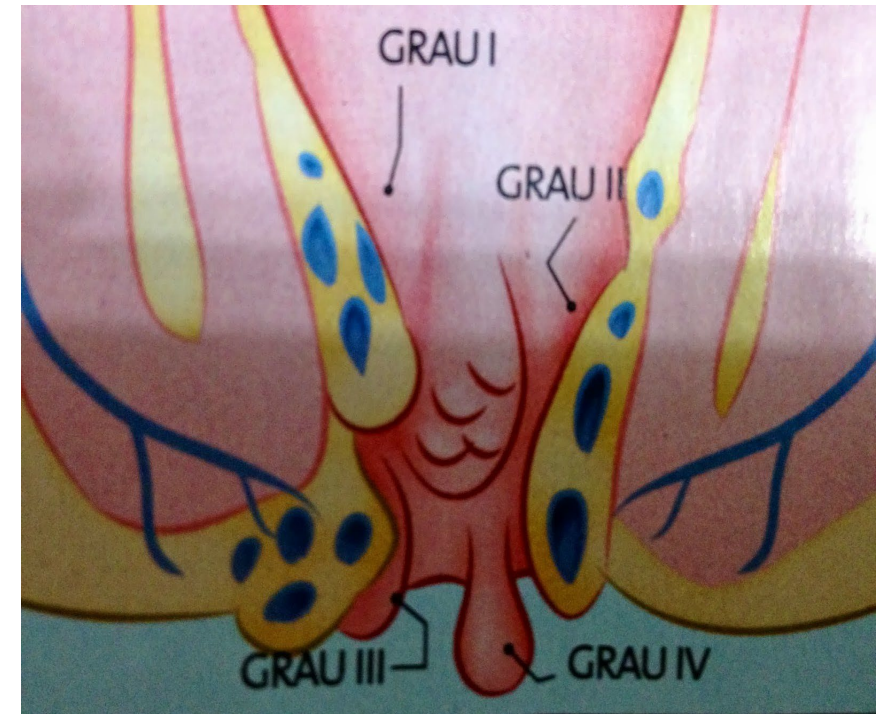
1. Deus, J. R., & Rama, N. Doença Hemorroidária-Recomendações (Guidelines) Hemorrhoidal Disease-Guidelines. Janeiro/Abril 2020.
2. Sun, Z., & Migaly, J. (2016). Review of hemorrhoid disease: presentation and management. Clinics in colon and rectal surgery, 29(01), 022-029.
3. Guttenplan, M. (2017). The evaluation and office management of hemorrhoids for the gastroenterologist. Current gastroenterology reports, 19(7), 1-8.
4. Salgueiro, P., Caetano, A. C., Oliveira, A. M., Rosa, B., Mascarenhas-Saraiva, M., Ministro, P., ... & Castro-Poças, F. (2020). Portuguese Society of Gastroenterology Consensus on the Diagnosis and Management of Hemorrhoidal Disease. GE-Portuguese Journal of Gastroenterology, 27(2), 90-102.

Classificação

Doença hemorroidária

► Hemorroidas Internas

- **Grau I** - Rectorragias, sem prolapso
- **Grau II** - Prolapso com o esforço, redução espontânea
- **Grau III** - Prolapso com o esforço, necessita de redução manual
- **Grau IV** - Prolapso permanente, não redutível



www.googleimages.com

Sintomatologia

- ▶ **Dor** (*as hemorroidas externas não causam dor, excepto se houver trombose!*)
- ▶ **Rectorragias**
- ▶ **Prurido anal**
- ▶ **Tumefacção perianal**
- ▶ **INCONTINÊNCIA SE PROLAPSO GRANDE**

Complicações: hemorragia; trombose; estrangulamento; necrose

1. Gittenplan, M. (2017). The evaluation and office management of hemorrhoids for the gastroenterologist. Current gastroenterology reports, 19(7), 1-8.

2. Salgueiro, P., Caetano, A. C., Oliveira, A. M., Rosa, B., Mascarenhas-Saraiva, M., Ministro, P., ... & Castro-Poças, F. (2020). Portuguese Society of Gastroenterology Consensus on the Diagnosis and Management of Hemorrhoidal Disease.

GE-Portuguese Journal of Gastroenterology, 27(2), 90-102.

Diagnóstico

▶ História clínica completa

- ▶ incluindo hábitos alimentares; detalhe dos hábitos intestinais (frequência, consistência, textura, forma)

▶ Exame físico

- ▶ idealmente com anoscopia e retoscopia

▶ Estudo complementar

- ▶ defecografia; manometria anal; ...

▶ Se houver suspeita de outras etiologias

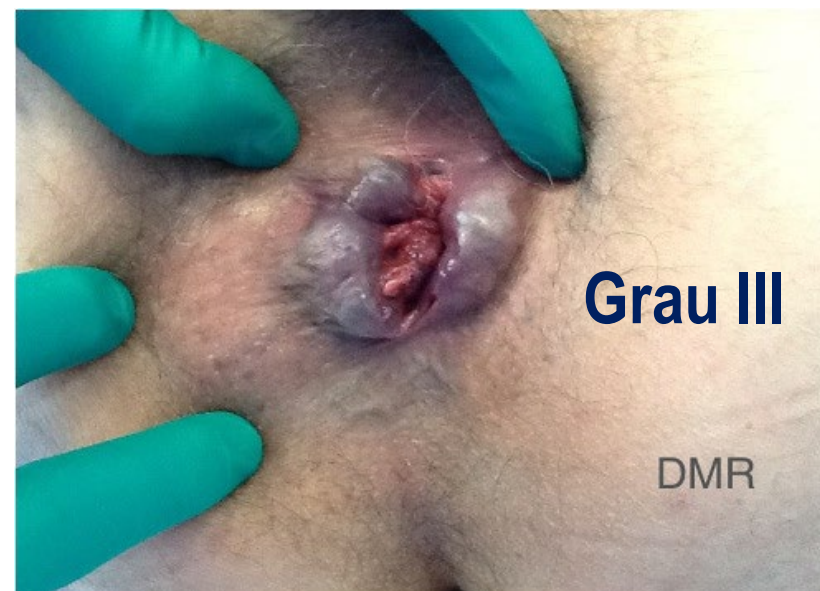
- ▶ sigmoidoscopia rígida ou flexível; colonoscopia total; enema duplo contraste; TAC; ...

1. Guttentplan, M. (2017). The evaluation and office management of hemorrhoids for the gastroenterologist. Current gastroenterology reports, 19(7), 1-8.

2 Salgueiro, P., Caetano, A. C., Oliveira, A. M., Rosa, B., Mascarenhas-Saraiva, M., Ministro, P., ... & Castro-Poças, F. (2020). Portuguese Society of Gastroenterology Consensus on the Diagnosis and Management of Hemorrhoidal Disease. GE-Portuguese Journal of Gastroenterology, 27(2), 90-102.

Exame Físico

Doença hemorroidária



Tratamento

- ▶ **O tratamento é determinado pela severidade dos sintomas**
 - ▶ **Médico:**
 - ▶ Farmacológico
 - ▶ Não-farmacológico
 - ▶ **Instrumental**
 - ▶ muito útil nas hemorróidas internas
 - ▶ não tem utilidade nas hemorróidas externas
 - ▶ **Cirúrgico**

1. Guttenplan, M. (2017). The evaluation and office management of hemorrhoids for the gastroenterologist. Current gastroenterology reports, 19(7), 1-8.

2 Salgueiro, P., Caetano, A. C., Oliveira, A. M., Rosa, B., Mascarenhas-Saraiva, M., Ministro, P., ... & Castro-Poças, F. (2020). Portuguese Society of Gastroenterology Consensus on the Diagnosis and Management of Hemorrhoidal Disease.

GE-Portuguese Journal of Gastroenterology, 27(2), 90-102.

Tratamento Médico

- ▶ Incentivo ao **exercício físico**
- ▶ Dieta rica em **fibras** e aumento da ingestão de **água**
- ▶ **Laxantes** (o seu uso a longo prazo deve ser evitado!!!)
- ▶ **Tópicos**: analgésicos; antiinflamatórios; emolientes; vasoconstritores
 - ▶ Aliviam a dor, mas não têm efeito sobre as rectorragias ou o prolapso
 - ▶ o seu uso prolongado não é aconselhado (período máximo de 7 dias).

1. Guttenplan, M. (2017). The evaluation and office management of hemorrhoids for the gastroenterologist. Current gastroenterology reports, 19(7), 1-8.

2 Salgueiro, P., Caetano, A. C., Oliveira, A. M., Rosa, B., Mascarenhas-Saraiva, M., Ministro, P., ... & Castro-Poças, F. (2020). Portuguese Society of Gastroenterology Consensus on the Diagnosis and Management of Hemorrhoidal Disease. GE-Portuguese Journal of Gastroenterology, 27(2), 90-102.

Tratamento Médico

- ▶ Analgésicos e AINE's **sistêmicos**
 - ▶ têm utilidade sobretudo no alívio dos sintomas das **hemorroidas trombosadas**
- ▶ Flebotónicos
 - ▶ hemorroidas 1º e 2º Grau
 - ▶ trombose hemorroidária
 - ▶ após hemorroidectomia
 - ▶ benefício comprovado no prurido, hemorragia e hemorragia pós hemorroidectomia

1. Gittenplan, M. (2017). The evaluation and office management of hemorrhoids for the gastroenterologist. Current gastroenterology reports, 19(7), 1-8.

2 Salgueiro, P., Caetano, A. C., Oliveira, A. M., Rosa, B., Mascarenhas-Saraiva, M., Ministro, P., ... & Castro-Poças, F. (2020). Portuguese Society of Gastroenterology Consensus on the Diagnosis and Management of Hemorrhoidal Disease.

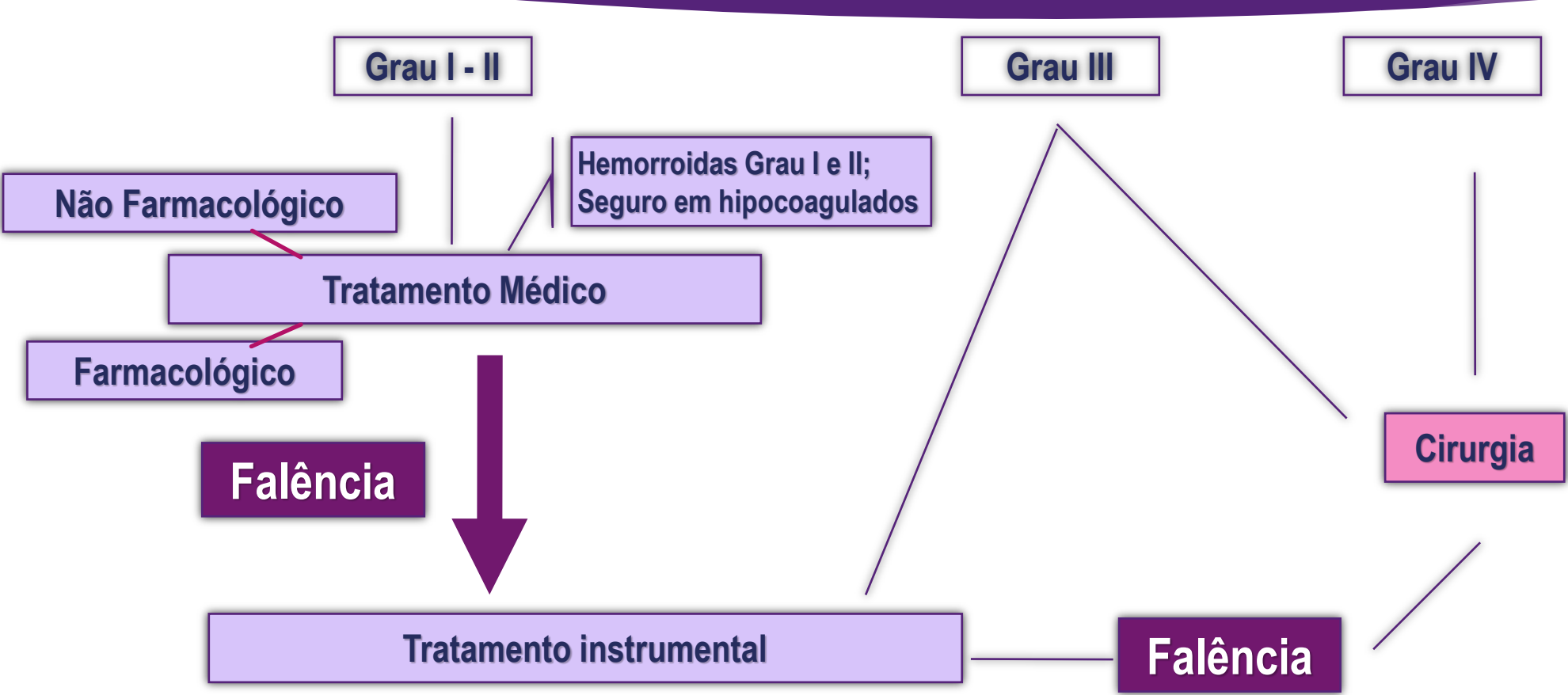
GE-Portuguese Journal of Gastroenterology, 27(2), 90-102.







Hemorróidas - Resumo

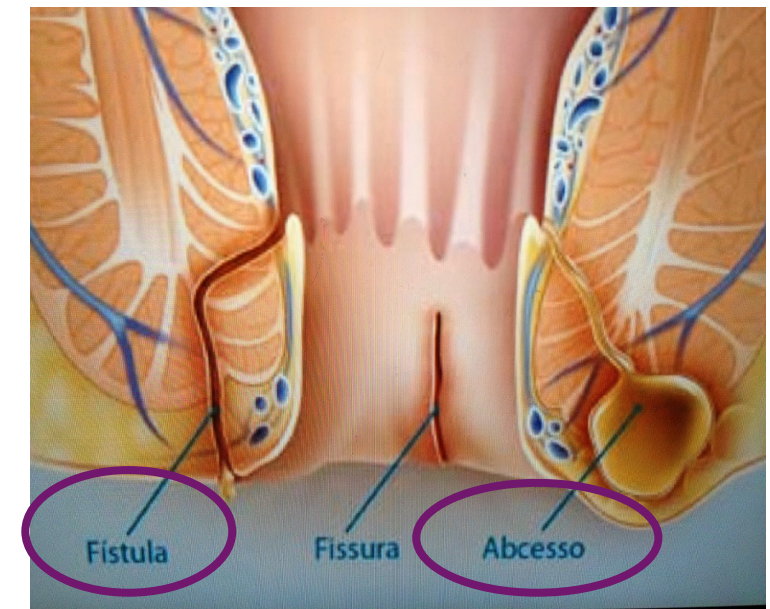


1.Paredes, V. e Atienza, P. - Hemorroides. Enciclopédia Médico-Cirurgicale, E, 40-685
2 Deus, J. R., & Rama, N. Doença Hemorroidária-Recomendações (Guidelines) Hemorrhoidal Disease-Guidelines. Janeiro/Abril 2020.

ABCESSOS E FÍSTULAS ANAIS

Definição

- ▶ **Abcessos e fístulas anais** - fases evolutivas da mesma doença
- ▶ **Criptite piogénica** - 1ª fase do processo supurativo, caracterizando-se pela retenção de pús e formação do **abcesso**
- ▶ **Fístula anal** - consideradas abcessos crónicos do ânus e surgem quando os abcessos são drenados cirurgicamente ou espontaneamente, formando-se uma comunicação anormal entre o canal anal e a pele perianal



www.googleimages.com

Sintomatologia

► Fase aguda - abcesso

- Dor continua sem relação com a defecação
- Hipertermia e rubor perianal
- Induração perianal ou rectal
- Tumefacção perianal ou rectal muito dolorosa



► Fase crónica - fístula

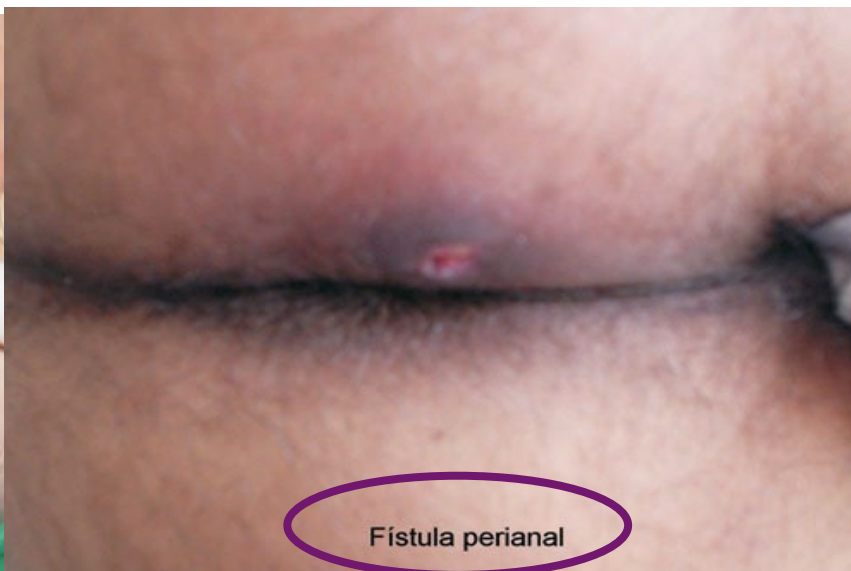
- Orifício externo com drenagem de pús/sangue/fezes
- Prurido
- Trajecto fistuloso palpável

Os sintomas podem ir alternando entre fases de agudização e sintomas de cronicidade

Exame físico



Exame físico



Fístula perianal



Tratamento

- ▶ É **cirúrgico** e deve ser realizado **o mais precocemente possível** afim de evitar complicações como infecção sistémica
- ▶ Drenagem (a ausência de flutuação não implica alteração da atitude)
- ▶ O uso de ATB não está indicado, excepto se:
 - ▶ imunodeprimidos; diabéticos; celulite extensa; patologia valvular



MEDO DAS HEMORRÓIDAS...???



Retilyv

Mercados de Luanda prometem cura para quase tudo com medicamentos tradicionais

**STOP
MITOS!!**



Ervas, raízes, folhas e até fezes de animais continuam a representar um negócio em alguns mercados de Luanda,

Agência Lusa
Texto



Retilyv

SOS HEMORROIDAS



Retilyv

Policresuleno 50mg/g +
Cloridrato de cinchocaina 10mg/g

Retilyv

Policresuleno 50mg/g +
Cloridrato de cinchocaína 10mg/g

ACÇÃO 5 EM 1

POLICRESULENO (50 mg/g)

- **Ácido** orgânico (pH=4).
- Mecanismo de acção único.
- **Efeito rápido.**

Cloridrato de CINCHOCAÍNA (10 mg/g)

- **Anestésico** local.
- Elevada **potência**.
- **Rápido** início de acção (15 min).
- **Longa duração** de acção (até 4 horas).

Composição

POLICRESULENO Ácido orgânico (pH=4).

- Mecanismo de acção único.
 - **Efeito rápido.**

PÁRA A HEMORRAGIA

Efeito **hemostático**, causando **vasoconstrição** dos capilares sanguíneos e parando a hemorragia **de forma rápida e prolongada.**

CICATRIZA A FERIDA

Promove a **reepitelização e regeneração** da pele.

SELECTIVO NA LESÃO

Coagula e **elimina selectivamente o tecido necrótico**, mantendo o tecido saudável inalterado. Deste modo, **estimula a rápida recuperação** da ferida.

ANTIMICROBIANO

Acção **bactericida e fungicida** contra os principais patogéneos anais*, **impedindo a infecção secundária e prevenindo a inflamação**, sem risco de resistência bacteriana.

* Staphilococcus, Streptococcus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Candida albicans.

Composição

CINCHOCAÍNA *Anestésico local.*

- Elevada **potência**.
- **Rápido** início de acção (15 min).
- **Longa duração de acção** (até 4 horas).

ALÍVIO RÁPIDO DA DOR

Efeito anestésico, restringe reversível e localmente a sensibilidade e o volume dos nervos sensoriais para alívio rápido da dor e prurido.

Retilyv

Policresuleno 50mg/g +
Cloridrato de cinchocaína 10mg/g

Aplicador
cômodo
para difusão
eficaz da
pomada e
maior
conforto

Alívio rápido
da dor

Eficaz no
tratamento
das
hemorroidas

**RETILYV ALIVIA
RAPIDAMENTE A DOR E
O PRURIDO, PÁRA A
HEMORRAGIA E
EXSUDAÇÃO E DIMINUI
A INFLAMAÇÃO,
PROMOVENDO A
REGENERAÇÃO DO
TECIDO AFECTADO**

Bem
tolerado,
sem efeitos
secundários
sistêmicos

Pára a
hemorragia

Diminui a
inflamação,
prurido e
impede a
exsudação

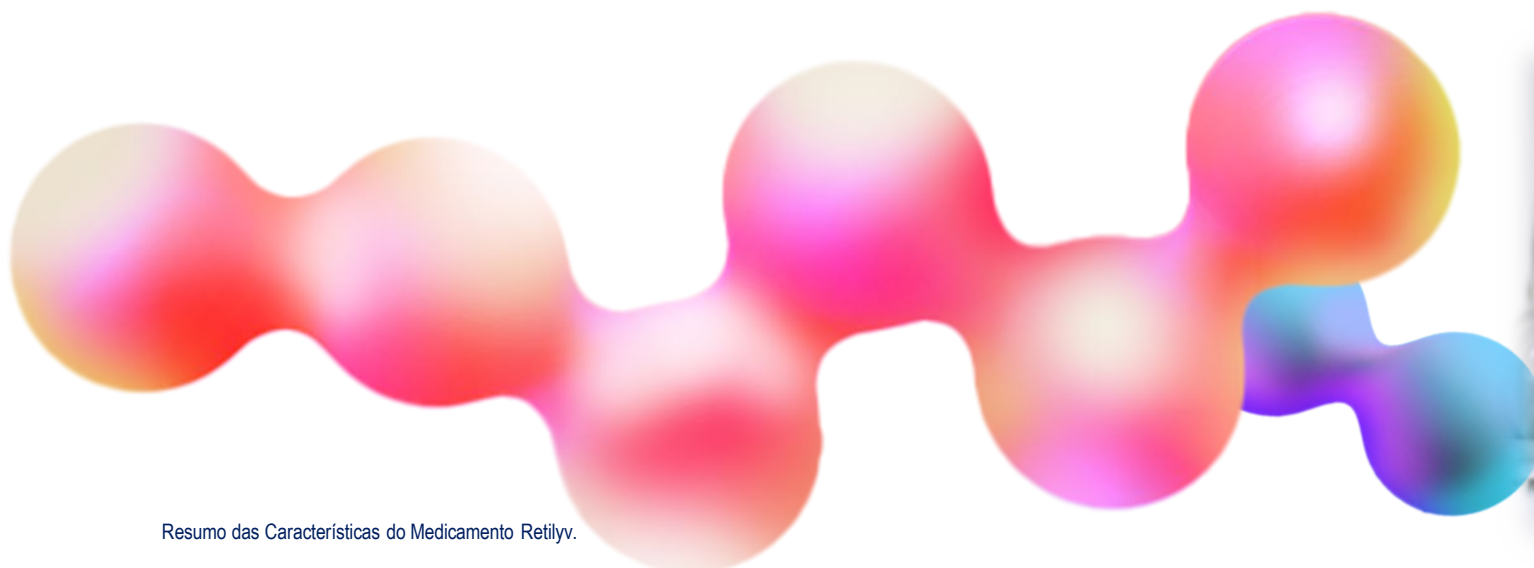
Cicatriza a
ferida

Previne a
infecção

Quando indicar?



- Tratamento de **hemorroidas não complicadas, fissuras, prurido e eczema anal**, após diagnóstico médico prévio.



Posologia

- ▶ Aplicar a **pomada sobre as lesões, 2-3 vezes por dia.**
- ▶ **Período máximo de 7 dias.**

INCLUI UM APLICADOR CÓMODO, SIMPLES E PRÁTICO, PERMITINDO:

- Difusão eficaz da pomada
- Maior conforto

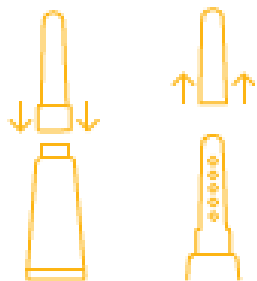


Posologia

- Aplicar a **pomada sobre as lesões, 2-3 vezes por dia.**

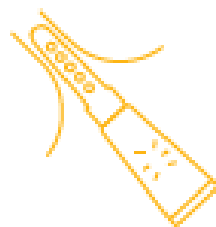
APLICAÇÃO INTERNA

01



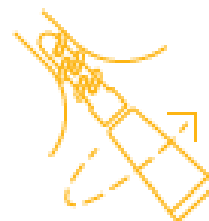
- Retirar a tampa do tubo.
- Adaptar o aplicador à bisnaga.
- Remover a tampa do aplicador.

02



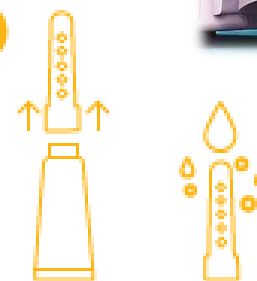
- Introduzir o aplicador no recto.
- Pressionar ligeiramente a bisnaga.

03



- Girar lentamente a bisnaga, enquanto a pressiona, permitindo uma distribuição uniforme da pomada na zona afectada.

04



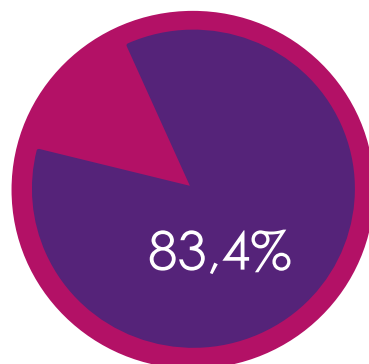
- Retirar o aplicador do recto.
- Removê-lo da bisnaga e higienizá-lo cuidadosamente.



Eficácia de Retilyv

Retilyv é responsável por **sucesso terapêutico em +80%** dos casos de tratamento de **hemorroidas internas e externas**. As **lesões** foram **curadas ou francamente melhoradas**, além de um **alívio** acentuado na sintomatologia hemorroidária.

Taxa de
Sucesso



83,1%

Avaliação do Médico

82,2%

Avaliação do Paciente

1. Espinosa, D. J. (2000). Revisión analítica de estudios multicéntricos con policresuleno en patología hemorroidal. Acta gastroenterol. latinoam, 177-86.
2. Brandes, H. (1982). A multicenter trial with the steroid-free hemorrhoidal preparation faktu (author's transl). MMW, Munchener Medizinische Wochenschrift, 124(Suppl 1), 37-40.
3. Arnold, K., & Auel, H. (1976). Multicenter clinical study of a novel steroid-free preparation in proctology. Arzneimittel-forschung, 26(1), 96-99.
4. Froehner Junior, I., Kotze, P. G., Rocha, J. G., Miranda, E. F., Sartor, M. C., Martins, J. F., ... & Correa, M. F. (2014). Postoperative topical analgesia of hemorrhoidectomy with policresulen and cinchocaine: a prospective and

Retilyv

Policresuleno 50mg/g +
Cloridrato de cinchocaína 10mg/g

Eficácia Retilyv nas diferentes patologias

81,4%

HEMORRÓIDAS INTERNAS

Paragem da hemorragia e alívio dos sintomas inflamatórios.

86,4%

HEMORRÓIDAS EXTERNAS

Rápido alívio da dor.

83,6%

ECZEMA E PRURIDO

Propriedades **antimicrobianas**, **adstringentes** e **restabelecimento do pH** numa zona em que a humidade, temperatura e pH tendem a atrasar o processo de cicatrização

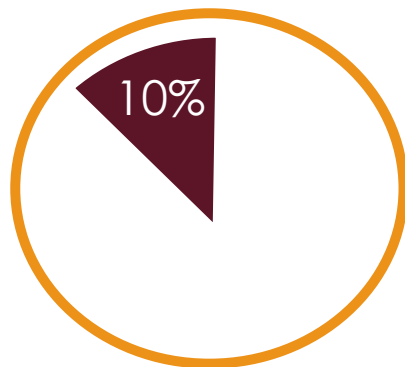
1. Espinosa, D. J. (2000). Revisión analítica de estudios multicéntricos con policresuleno en patología hemorroidal. Acta gastroenterol. latinoam, 177-86.

2. Brandes, H. (1982). A multicenter trial with the steroid-free hemorrhoidal preparation faktu (author's transl). MMW, Munchener Medizinische Wochenschrift, 124(Suppl 1), 37-40.

3. Arnold, K., & Auel, H. (1976). Multicenter clinical study of a novel steroid-free preparation in proctology. Arzneimittel-forschung, 26(1), 96-99.

4. Froehner Junior, I., Kotze, P. G., Rocha, J. G., Miranda, E. F., Sartor, M. C., Martins, J. F., ... & Correa, M. F. (2014). Postoperative topical analgesia of hemorrhoidectomy with policresulen and cinchocaine: a prospective and

Tolerabilidade do Retilyv



EVENTOS ADVERSOS



Os **eventos adversos** reportados foram **ligeiros a moderados**, sendo os principais *desconforto local, prurido e irritação*.

Na **maioria** dos casos, os eventos adversos **não obrigaram à interrupção** do tratamento. Apesar do seu pH ácido, o policresuleno não é tóxico quando aplicado localmente.

POR NÃO CONTER CORTICOSTERÓIDES, RETILYV PODE SER UTILIZADO POR LONGOS PERÍODOS DE TEMPO, SEM EFEITOS SECUNDÁRIOS SISTÊMICOS

Retilyv

Policresuleno 50mg/g +
Cloridrato de cinchocaina 10mg/g

Tolerabilidade do Retilyv

QUAIS OS RISCOS DOS CORTICOIDES TÓPICOS?

- Dermatite de contacto por sensibilização
- Hipo ou hiperpigmentação cutânea
 - Atrofia dérmica ou epidérmica
 - Efeito 'rebound'
 - Taquifilaxia



Retilyv

Poliresuleno 50mg/g +
Cloridrato de cinchocalina 10mg/g

Tolerabilidade do Retilyv

A Ciência

Tabla VIII: Eficacia terapéutica global en 2287 casos según el criterio de los investigadores y de los pacientes.

Eficacia terapéutica	Según los investigadores		Según los pacientes	
	nº	%	nº	%
Muy bueno/bueno	1904	83,2	1881	82,2
Regular	230	10,0	175	7,6
No satisfactorio	83	3,6	120	5,2
Empeoramiento	28	1,2	25	1,0
No especificado	42	2,0		
El paciente no sabe definir			86	4,0
Total	2287	100,0	2287	100,0

Tabla I: Cantidad total de p
tro.

Diagnósticos
Hemorroides externas
Hemorroides internas
Fistula anal
Fisura anal
Ulceras (rágades)
Eccema y prurito anal
Proctitis
Postoperatorio cirugía proctológica
Prolapso anal
Total de pacientes
Total de diagnósticos

No actorio	Exarcepción	Sin datos	Totales
25	2	15	912
12	7	16	894
2	1	0	10
9	6	1	360
4	0	1	176
28	8	14	814
6	3	5	287
3	2	4	233
0	0	0	4
39	29	56	3690
8%)	(0,8%)	(1,5%)	(100,0%)

Retilyv

Policresuleno 50mg/g +
Cloridrato de cinchocaina 10mg/g

Recomendações



MUDANÇAS ESTILO DE VIDA

- ✓ Aumentar a **ingestão de fluídos**.
- ✓ Aumentar a ingestão **de alimentos ricos em fibra**.
- ✓ Reduz o risco de rectorragias e persistência dos sintomas em 50%.
- ✓ **Evitar esforço** na defecação.
- ✓ Praticar regularmente **exercício físico**.
- ✓ **Diminuir** o consumo de **gorduras, alimentos picantes e álcool**.



TRATAMENTO FARMACOLÓGICO



1. Espinosa, D. J. (2000). Revisión analítica de estudios multicéntricos con policresuleno en patologia hemorroidal. Acta gastroenterol. latinoam, 177-86.

2. Brandes, H. (1982). A multicenter trial with the steroid-free hemorrhoidal preparation faktu (author's transl). MMW, Munchener Medizinische Wochenschrift, 124(Suppl 1), 37-40.

Diga: NÃO AO ESTIGMA!



01 Patologias anorectais são extremamente frequentes!

02 Podem ser reduzidas com mudança de hábitos.

03 Podem ser tratadas com medicamentos e, em casos mais graves, com cirurgia.



Retilyv

VERDADEIRO

OU

FALSO

- ✓ Não há uma causa única que explique o seu aparecimento.
- ✓ Os idosos estão mais vulneráveis ao aparecimento de hemorroidas.
- ✓ A obstipação intestinal contribui para o aparecimento de hemorroidas.
- ✓ Quem sofre de hemorroidas pode praticar exercício físico.
- ✓ É possível prevenir o aparecimento de hemorroidas.
- ✓ Quanto mais cedo tratar as hemorroidas, menos complicações terá.



- ✗ As hemorroidas provocam sempre dores.
- ✗ As hemorroidas podem evoluir para cancro.
- ✗ As hemorroidas não estão associadas a outras doenças anais.
- ✗ O tratamento é doloroso e prolongado.

CASOS CLÍNICOS

*Disclaimer: Casos clínicos fictícios da autoria da Dra. Ana Vilaça, Especialista em Medicina Interna.
Patrocinado por Bial.*

Retilyv

Policresuleno 50mg/g +
Cloridrato de cinchocaina 10mg/g

Caso Clínico 1

- **Lukeny, homem de 48 anos, casado, empresário.**
- **Antecedentes Pessoais:**
 - Obesidade
 - HTA
 - Dislipidemia
 - Fibrilhação auricular
- **Medicação Habitual:**
 - Ramipril 5mg/dia;
 - Atorvastatina 10mg/dia
 - Rivaroxabano 2,5mg duas vezes por dia
- **Hábitos de vida e dietéticos:**
 - Refere dieta mais rica em farinhas (*funge*), não come muitos legumes e prefere comida picante. Bebe geralmente Cuca® às refeições.
 - Não pratica exercício físico.

- **Queixa principal:**

O doente conta que tem **rectorragias** “*episódios de sangue vivo no papel higiénico quando se limpa após defecar*” (sic) e **dor na região anal**: “*parece que tenho cactos a espetar*” (sic). Estes episódios ocorrem de forma mais recorrente há cerca de um ano.



Caso Clínico 1

➤ Ao exame físico:

- Peso= 85 kg
- Estatura = 1,68 m
- Anuscopia com tumefação interna compatível com **hemorroidas interna Grau I**
- Sem outras alterações de relevo

O que fazer? Tratamento Médico

➤ Farmacológico:

- **Tópicos:** analgésicos; anti-inflamatórios; emolientes; vasoconstritores como Retilyv®

➤ Não-farmacológico

- Incentivo ao **exercício físico**
- Dieta rica em **fibras** (evitando ainda assim alguns legumes verdes e preferir sempre frutas descascadas, pela interferência com o Rivaroxabano)!
- Aumento da ingestão de **água!**
- Considerar MCD's diagnóstico se não houver melhoria.

Caso Clínico 2

- **Tchissola, mulher de 25 anos, casada, 4 filhos, funcionária num hotel.**
- **Antecedentes Pessoais:**
 - Três partos eutócicos, o último há um ano.
- **Medicação Habitual:**
 - Nenhuma
- **Hábitos dietéticos e de vida:**
 - Dieta variada, bebe água às refeições.
 - Caminhadas de 15 minutos a pé para o trabalho.
 - Passa todo o seu dia de pé.

- **Queixa principal:**

A doente conta que tem **rectorragias** ocasionais, **prurido anal** e **muita dor** quando defeca “tenho muito comichão e quando defeco é com se estivesse a ser arranhada” (sic); referia ainda que, por vezes, tinha **exsudado translúcido** quando se limpava. Conta ainda que estes episódios se agravaram após o 3º parto.

- **Ao exame físico:**

- Peso= 59 kg
- Estatura = 1,60 m
- Anuscopia compatível com fissura anal.
- Sem outras alterações de relevo



Caso Clínico 2

O que fazer: Tratamento Médico

➤ Farmacológico:

- **Tópicos:** analgésicos como por exemplo o Retilyv®
- **Corticóides tópicos**
- **Pomada Nitroglicerina (NTG)**
- **Bloqueadores canais de cálcio**

➤ Não-farmacológico:

- Incentivo ao **exercício físico**
- Dieta rica em **fibras**
- Aumento da ingestão de **água**
- **Banhos de assento** (após a defecação, imersão em água morna 2-5 min, seguida de imersão em água à temperatura ambiente por 1 minuto)
- Considerar MCD's diagnóstico se não houver melhoria.

Caso Clínico 3

- **Otniel, homem de 38 anos, casado, pedreiro.**
- **Antecedentes Pessoais:**
 - Irrelevantes
- **Medicação Habitual:**
 - Nenhuma
- **Hábitos dietéticos e de vida:**
 - Alimentação pouco variada, almoça todos os dias numa “cantina”, sem ingestão de legumes ou fruta. As comidas são preferencialmente picantes. Não bebe água durante o dia.
 - Não pratica desporto, mas trabalha com cargas pesadas todos os dias.

- **Queixa principal:**

O doente conta que, **desde que começou a carregar mais pesos diariamente**, iniciou quadro de **dor e prurido anal** com rectorragias (**sangue vivo**) **nas fezes** (apesar de não acontecer diariamente). Contudo, não procurou ajuda profissional. Após cerca de dois anos **o quadro agravou** e quando se limpava **após defecação, sentia uma proeminência externa** “tenho um papinho que depois vai para dentro” (sic). Esta proeminência não era muito dolorosa e, **manualmente, interiorizava-se novamente.**



Caso Clínico 3

➤ Ao exame físico:

- Peso= 73 kg
- Estatura = 1,77 m
- Anuscopia compatível com **hemorroida**

Interna Grau 2

- Sem outras alterações de relevo

O que fazer? Tratamento Médico

➤ Farmacológico:

- **Tópicos:** analgésicos; anti-inflamatórios; emolientes; vasoconstritores como Retilyv®

➤ Não-farmacológico

- **Reduzir à quantidade de peso que carrega da cada vez.**
- Dieta rica em **fibras** e aumento da ingestão de **água!**
- Considerar MCD's diagnóstico se não houver melhoria.

Caso Clínico 4

- **Luana, mulher de 35 anos, casada, 5 filhos, secretária de escritório.**
- **Antecedentes Pessoais:**
 - Obstipação
 - Excesso de peso
- **Medicação Habitual:**
 - Nenhuma
- **Hábitos dietéticos e de vida:**
 - Alimentação pouco variada; às vezes não almoça, come fruta duas vezes por semana!
 - Ingere pouca água “*não me lembro de beber*” (sic)
 - Não pratica exercício físico

- **Queixa principal:**

A doente conta **que tem obstipação** há anos e passa **períodos prolongados sentada na sanita** para que o intestino funcione. O quadro tem-se vindo a agravar e agora recorre por **queixas de rectorragia** “*com sangue vivo na sanita*” (sic) após defecar, **fezes duras e dor**, “*como se me tivesse arranhado em arame farpado*” (sic).



Caso Clínico 4

➤ Ao exame físico:

- Peso= 65 kg
- Estatura = 1,58 m
- Anuscopia compatível com **hemorroida Interna Grau 1**
- Sem outras alterações de relevo

O que fazer? Tratamento Médico

➤ Farmacológico:

- **Tópicos:** analgésicos; anti-inflamatórios; emolientes; vasoconstritores como Retilyv®
- Laxantes (embora seu uso a longo prazo deve ser evitado!!!)

➤ Não-farmacológico

- Aumentar a ingestão de **fibras com legumes/frutas diariamente** e aumento da ingestão de **água!**
- **Prática de exercício físico diário pelo menos 30 a 45 min/dia**

Take Home Messages

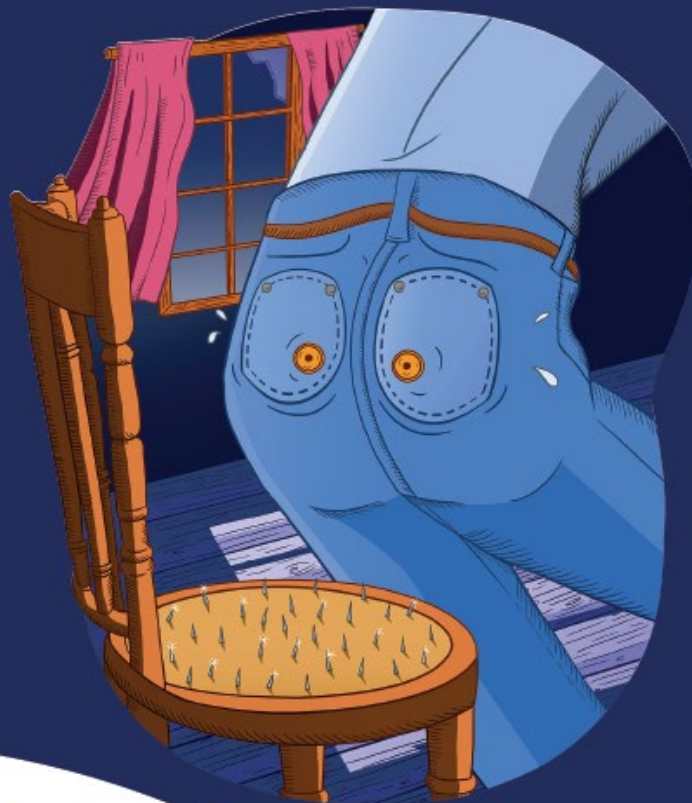
- ▶ A **patologia ano-rectal** benigna é extremamente **frequente**.
- ▶ A **história clínica e o exame físico** são muito importantes para o **diagnóstico**.
- ▶ As **medidas preventivas** como **cuidados dietéticos, ingestão de água e exercício físico** são **fundamentais**.
- ▶ O **tratamento médico** (farmacológico e não farmacológico) a maioria das vezes é **eficaz (> 80% dos casos)** e muito **bem tolerado**.
- ▶ Quanto **mais precocemente for iniciado, menos complicações** os pacientes sofrem (e por isso é importante que se *abordem estes temas sem tabus* com os pacientes).
- ▶ O **uso de analgésicos e anestésicos tópicos como o Retilyv®**:
 - ▶ são **muito benéficos** quer no alívio da dor, quer na prevenção de complicações;
 - ▶ são de **muito fácil aplicação**;
 - ▶ têm **baixa taxa de efeitos adversos**;
 - ▶ podem ser **usados de forma segura durante 7 dias**.

Retilyv

Policresuleno 50mg/g +
Cloridrato de cinchocaína 10mg/g

MEDO DAS HEMORROIDAS?

Bial



Retilyv
SOS HEMORROIDAS
ALÍVIO RÁPIDO E EFICAZ



Bibliografia

- ▶ Amaro, P. e Duarte, A. - Fissura anal Parte I - Fundamentos Teóricos. Revista Portuguesa de Coloproctologia, Jan-abr (2009), p. 18-26
- ▶ Amaro, P. e Duarte, A. - Fissura anal Parte II - Abordagem prática. Revista Portuguesa de Coloproctologia, Jan-abr (2009), p. 30-32
- ▶ Perry, W., Dykes, S., Bule, W e Rafferty, J - "Practice Parameters for the Management of Anal Fissures (3rd Revision)". Diseases of the Colon & Rectum, Vol. 53:8 (2010), p. 1110-1115
- ▶ Rakinic, J. e Poola, V. - Hemorrhoids and Fistulas: New Solutions to Old Problems. Current Problems in Surgery, Vol. 53, 3 (2014), p. 98-137
- ▶ Rivadeneira, D., Steele, S., Ternet, C., Chalasani, S., Buie, W. e Rafferty, J. - "Practice Parameters for the Management of Hemorrhoids (Revised 2010)". Diseases of the Colon & Rectum, Vol. 54:9 (2011), p. 1059-1064
- ▶ Paredes, V. e Atienza, P. - Hemorroides. Enciclopédia Médico-Cirurgicale, E, 40-685
- ▶ Martins, I. e Pereira, J. - Supurações Perianais Abscessos e Fistulas Anais. Revista Portuguesa de Coloproctologia, 7(3) (2010), p. 118-124
- ▶ Deus, J. R., & Rama, N. Doença Hemorroidária-Recomendações (Guidelines) Hemorrhoidal Disease-Guidelines. Janeiro/Abril 2020.
- ▶ Sun, Z., & Migaly, J. (2016). Review of hemorrhoid disease: presentation and management. Clinics in colon and rectal surgery, 29(01), 022-029.
- ▶ Guttentplan, M. (2017). The evaluation and office management of hemorrhoids for the gastroenterologist. Current gastroenterology reports, 19(7), 1-8.
- ▶ Salgueiro, P., Caetano, A. C., Oliveira, A. M., Rosa, B., Mascarenhas-Saraiva, M., Ministro, P., ... & Castro-Poças, F. (2020). Portuguese Society of Gastroenterology Consensus on the Diagnosis and Management of Hemorrhoidal Disease. GE-Portuguese Journal of Gastroenterology, 27(2), 90-102.
- ▶ Espinosa, D. J. (2000). Revisión analítica de estudios multicéntricos con policresuleno en patología hemorroidal. Acta gastroenterol. latinoam, 177-86.
- ▶ Resumo das Características do Medicamento Retilyv.
- ▶ Brandes, H. (1982). A multicenter trial with the steroid-free hemorrhoidal preparation faktu (author's transl). MMW, Munchener Medizinische Wochenschrift, 124(Suppl 1), 37-40.
- ▶ Arnold, K., & Auel, H. (1976). Multicenter clinical study of a novel steroid-free preparation in proctology. Arzneimittel-forschung, 26(1), 96-99.
- ▶ Froehner Junior, I., Kotze, P. G., Rocha, J. G., Miranda, E. F., Sartor, M. C., Martins, J. F., ... & Correa, M. F. (2014). Postoperative topical analgesia of hemorrhoidectomy with policresulen and cinchocaine: a prospective and controlled study. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 41, 092-098.

Retilyv

Policresuleno 50mg/g +
Cloridrato de cinchocaina 10mg/g

O que é o Retilyv

O policresuleno é uma substância obtida por síntese que se caracteriza pela sua acidez, que no composto concentrado atinge um pH de 0,6. Para uso em proctologia, com o objetivo de otimizar a tolerabilidade pelas mucosas, o concentrado puro foi tamponado a um pH de 4,111. O policresuleno tem ação hemostática e anti-hemorragica por coagular as proteínas do sangue e induzir uma contração rápida e intensa das fibras musculares dos vasos sanguíneos de pequeno calibre. A aplicação em tecidos necróticos ou patologicamente alterados provoca a descamação dos tecidos alterados de forma seletiva, sem alterar os tecidos saudáveis, promovendo assim condições favoráveis para a cicatrização. Foi estabelecido que esta ação seletiva do policresuleno pelos tecidos alterados se deve à sua condição de poliânion carregado negativamente, razão pela qual ele não reage com a mesma carga negativa da membrana fosfolipídica inalterada das células normais e reage com as membranas das células normais células, células alteradas que perderam a carga elétrica do referido signo. Isso resulta na desnaturação do A. Ge. O. -VOL. 30 - Pág. 177- proteínas da superfície das células alteradas com a remoção dos tecidos necróticos e limpeza da superfície sangüinolenta, permitindo a regeneração de! Tecido saudável que não foi afetado. !1i A alta acidez e propriedades coagulantes em as proteínas conferem propriedades antimicrobianas ao policresuleno. Essa ação foi verificada contra estafilococos, estreptococos, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris e Candida albicans.'11 Visto que esses agentes patogênicos são geralmente encontrados em dermatoses infectadas da região anal e perianal, sua eliminação juntamente com a ação desbridante de tecidos necróticos acelera os processos de cicatrização. A cinchocaína é um anestésico reconhecido para uso local do tipo amida. Sua alta potência e longa duração de ação o tornam o anestésico de escolha para uso local.

RCM Retilyv

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO

RETILYV 50 mg/g + 10 mg/g pomada rectal

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada grama de pomada contém 50 mg de Policresuleno e 10 mg de Cloridrato de Cinchocaína.

Excipiente com efeito conhecido:
Butil-hidroxitolueno (E321) - 1 mg/g

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Pomada rectal.
Pomada branca a acastanhada.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

RETILYV está indicado para o tratamento de: hemorroidas não complicadas, fissuras, prurido e eczema anal, após diagnóstico médico prévio.

4.2 Posologia e modo de administração

Posologia

Aplicar a pomada sobre as lesões, 2-3 vezes por dia.

Em caso de persistência de sintomas ao fim de sete dias de aplicação do medicamento, consulte o seu médico.

Modo de administração

Via rectal.

Para aplicação interna:

Adaptar o aplicador à bisnaga, remover a tampa do aplicador e introduzi-lo no recto. Com uma ligeira pressão sobre a bisnaga, a pomada sai pelos orifícios laterais do aplicador e espalha-se de forma uniforme sobre a zona afectada. Girando o aplicador, a pomada distribui-se em toda a volta. Em caso da aplicação interna de RETILYV é aconselhável uma evacuação prévia e higiene cuidada da zona afectada.

4.3 Contraindicações

Hipersensibilidade às substâncias activas ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Em caso de hipersensibilidade à Cinchocaina, RETILYV só deve ser utilizado com autorização expressa do médico.

Este medicamento contém butil-hidroxitolueno (E321). Pode causar reacções cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto) ou irritação ocular e das membranas mucosas.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interacção

Não convém aplicar na mesma lesão qualquer outro medicamento tópico, dado que não se pode excluir a possibilidade de interacção entre medicamentos.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Gravidez

O policresuleno só deve ser administrado durante a gravidez, por expressa indicação médica, se os benefícios para a mãe justificarem os possíveis riscos para o feto.

Não se dispõe de ensaios clínicos relativamente à segurança da utilização do policresuleno em mulheres grávidas. Os estudos realizados em animais não evidenciaram quaisquer indícios de efeitos teratogénicos.

Amamentação

Desconhece-se se o policresuleno é excretado no leite materno. Consequentemente, a utilização de RETILYV em mulheres a amamentar não é aconselhável, excepto se os benefícios justificarem os possíveis riscos para o recém-nascido.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Não foram estudados os efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

4.8 Efeitos indesejáveis

No início do tratamento podem surgir efeitos secundários locais, sob a forma de sensação de queimadura e prurido, relacionados com o mecanismo de acção do medicamento, mas geralmente desaparecem em pouco tempo, não sendo necessário suspender a terapêutica.

Notificação de suspeitas de reacções adversas

A notificação de suspeitas de reacções adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reacções adversas diretamente ao Responsável pela Colocação no Mercado.

4.9 Sobredosagem

Não foram descritos casos de sobredosagem.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: 6.7 - Aparelho digestivo. Anti-hemorroidários, código ATC: CO5A

A principal substância activa de RETILYV, o Policresuleno, é um ácido orgânico de elevado peso molecular com propriedades selectivas de precipitação de proteínas. O pH é 4.0. O policresuleno coagula o tecido necrótico ou patologicamente alterado, expelindo-o do organismo. O tecido adjacente

à área afectada não é afectado pelo policresuleno. O policresuleno actua como hemostático local, coagulando as proteínas sanguíneas e originando a contracção dos pequenos vasos sanguíneos. Deste modo, as hemorragias do canal anal e da região perianal são rapidamente controladas. Simultaneamente, o policresuleno induz a hiperemização reactiva da zona afectada, estimulando a cicatrização e promovendo a reepitelização.

O efeito antisséptico do policresuleno impede a infecção secundária da região ferida anorrectal. Deste modo, é prevenida a inflamação. As propriedades adstringentes de policresuleno impedem o aparecimento de exsudação, que é um sintoma frequentemente associado às hemorroidas.

A Cinchocaina, um anestésico local, restringe de modo reversível e localmente a sensibilidade e o volume dos nervos sensoriais. Deste modo, são eliminados a dor e o prurido, sintomas frequentes de afecções anorrectais.

A associação das duas substâncias activas policresuleno e cinchocaina elimina rapidamente a hemorragia, dor, prurido e exsudação, impede a inflamação e promove a regeneração do tecido afectado.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

- Farmacocinética geral

Em experiências com animais, após a administração oral de policresuleno, foi absorvida cerca de 10% da dose. A absorção após aplicação intravaginal ou intrarrectal local foi ligeiramente inferior, sendo cerca de 6-8%. Os constituintes de policresuleno absorvidos foram eliminados com semivida entre 4 e 5 horas. Não foi detectada qualquer biotransformação. O policresuleno administrado por via intravenosa foi eliminado principalmente através da urina, e menos de 10% foi excretado nas fezes, enquanto o fármaco administrado por via oral ou via rectal foi excretado principalmente nas fezes, devido à sua fraca absorção, e menos de 10% foi eliminado através da urina.

Não existem dados disponíveis sobre o perfil farmacocinético da cinchocaina provenientes de experiências com animais. Com base na prolongada experiência no Homem, prevê-se que apenas sejam absorvidas pequenas quantidades de cinchocaina após administração local na pele e nas membranas mucosas.

- Características em doentes/grupos especiais de indivíduos

Não aplicável

5.3 Dados de segurança pré-clínica

O policresuleno foi essencialmente não-tóxico após administração oral em ratos e ratinhos e moderadamente tóxico após administração intravenosa em ensaios de toxicidade aguda. A toxicidade de dose repetida de policresuleno caracterizou-se por efeitos irritantes locais após aplicação intrarrectal ou intravaginal. Não se observaram sinais que indicassem toxicidade sistémica, provavelmente devido à fraca absorção do policresuleno. Obtiveram-se resultados semelhantes após a administração oral do fármaco, que originou apenas efeitos gastrointestinais, como vómitos e diarreia, mas sem toxicidade sistémica. Não existem dados disponíveis sobre a toxicidade de dose repetida da cinchocaina.

Em ensaios de toxicidade na reprodução, o policresuleno não afectou a fertilidade feminina e não foi embriotóxico ou teratogénico. Observaram-se ligeiros efeitos fetotóxicos com dose igual ou superior a 300 mg/kg de peso corporal. Não existem dados disponíveis sobre os efeitos na reprodução mediados pela cinchocaina.

O policresuleno não foi mutagénico no Teste de Ames *in vitro*. Não existem dados disponíveis sobre os possíveis efeitos mutagénicos da cinchocaina. Para nenhuma destas substâncias se observaram sinais de carcinogenicidade nos ensaios disponíveis em animais.

A aplicação local de policresuleno originou ligeiros efeitos irritantes locais na pele e nas membranas mucosas do recto e da vagina. Para a cinchocaina, foram descritos casos únicos de sensibilização de contacto no Homem, indicando algum potencial sensibilizante do fármaco.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1. Lista dos excipientes

Butil-hidroxitolueno (E 321)
Edetato dissódico
Sílica coloidal anidra
Éter cetosteárilico de macrogol
Macrogol 300
Macrogol 1500
Macrogol 400
Hidróxido de sódio
Água purificada

6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

3 anos.

6.4 Precauções especiais de conservação

Não conservar acima de 25°C.

Possíveis alterações na cor da pomada não têm qualquer influência na eficácia do produto.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

Este medicamento é fornecido em bisnagas de alumínio de 30 g de pomada com aplicador.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento

Não existem requisitos especiais.

7. RESPONSÁVEL PELA COLOCAÇÃO NO MERCADO

BIAL - Portela & Cª, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado · Portugal
E-mail: info@bial.com

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Não aplicável.

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Não aplicável.

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO

03/2023